

1. Introducción y relevancia clínica

El **suicidio** constituye una **emergencia médica y de salud pública**.

Según la **OMS (2023)**, cada año mueren por suicidio más de **700.000 personas** en el mundo, siendo la **segunda causa de muerte entre los 15 y 29 años**.

En **Chile**, las tasas son crecientes, especialmente en adolescentes y adultos mayores, con una media nacional cercana a **11 por 100.000 habitantes**.

El **riesgo suicida** no es exclusivo de los trastornos depresivos, sino que se presenta en múltiples cuadros psiquiátricos (bipolaridad, esquizofrenia, consumo de sustancias, trastornos de personalidad).

El médico general, y en particular el médico en APS, tiene un rol fundamental en su **detección precoz, evaluación estructurada y derivación oportuna**.

□ En el **EUNACOM**, se pregunta con frecuencia:

- Cómo evaluar el riesgo suicida (factores de riesgo y de protección).
- Qué conductas tomar ante ideación activa o plan suicida.
- Qué estrategias de psicoeducación y seguimiento aplicar.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El suicidio resulta de una **interacción compleja entre vulnerabilidad biológica, psicológica y social**.

2.1. Factores neurobiológicos

- **Disminución de serotonina (5-HT)** y su metabolito 5-HIAA en el líquido cefalorraquídeo.
- **Alteraciones del eje hipotálamo–hipófisis–adrenal (HHA):** hipercortisolemia crónica.
- **Anomalías frontolímbicas:** menor control inhibitorio de impulsos.

- **Genética:** antecedentes familiares de suicidio aumentan el riesgo 2–4 veces.

2.2. Modelo psicológico

- **Teoría interpersonal del suicidio (Joiner):**
 - *Inutilidad percibida* (“mi vida no tiene sentido”).
 - *Desconexión social*.
 - *Capacidad adquirida* (habitación al dolor o miedo a la muerte).
 - **Modelo de estrés–vulnerabilidad:** factores predisponentes (depresión, abuso infantil, impulsividad) + factores precipitantes (pérdidas, conflicto agudo).
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

El **riesgo suicida** incluye todo el **espectro de pensamientos y conductas autodestructivas**, que van desde la **ideación pasiva** hasta el **acto suicida consumado**.

3.1. Fases clínicas

Fase	Características
Ideación suicida	Pensamientos de muerte (“no quiero vivir”), sin plan concreto.
Plan suicida	Idea estructurada con método, momento o lugar definidos.
Intento suicida	Acto autoinfligido con intención de morir, sin resultado fatal.
Suicidio consumado	Muerte como consecuencia directa del acto autoinfligido.

3.2. Signos de alarma

- Desesperanza (“nada va a cambiar”).
- Despedidas o entrega de objetos personales.
- Aislamiento o retraimiento repentino.
- Cambios abruptos en conducta, sueño o apetito.
- Disminución del interés por actividades habituales.
- Aparente calma tras un periodo de agitación (puede indicar “decisión final”).

3.3. Diagnóstico diferencial

Entidad	Características distintivas
Trastornos depresivos	Ánimo bajo predominante, ideación pasiva frecuente.
Trastorno bipolar	Riesgo elevado durante fases mixtas o depresivas.
Trastorno límite de la personalidad	Conductas suicidas impulsivas o de manipulación relacional.
Intoxicaciones o consumo de alcohol	Desinhibición e impulsividad aumentan el riesgo.
Duelo normal	Tristeza sin ideación activa de muerte.
☐ Regla de oro clínica: Nunca se debe minimizar la ideación suicida, aunque el paciente lo niegue parcialmente o “no lo diga en serio”.	

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Evaluación estructurada del riesgo suicida

El **MINSAL** recomienda una **entrevista clínica dirigida**, considerando **factores de riesgo, de protección y nivel de intencionalidad**.

Factores de riesgo

- **Psiquiátricos:** depresión mayor, bipolaridad, esquizofrenia, abuso de sustancias.
- **Psicosociales:** pérdidas recientes, soledad, desempleo, antecedentes de abuso.
- **Biológicos:** enfermedades crónicas, dolor persistente, antecedentes familiares.
- **Previos:** intentos suicidas anteriores (el predictor más importante).

Factores protectores

- Apoyo familiar y social.
 - Hijos pequeños o responsabilidades afectivas.
 - Creencias religiosas o morales protectoras.
 - Acceso a atención médica y seguimiento.
-

4.2. Instrumentos clínicos

- **Escala SAD PERSONS:** valora factores de riesgo en atención primaria.
 - **Columbia Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS):** valora ideación, plan e intento.
 - **Beck Scale for Suicidal Ideation (BSS):** cuantifica gravedad.
-

4.3. Estratificación del riesgo

Nivel	Características	Conducta
Alto riesgo	Plan definido, acceso a medios letales, intento reciente, sin red de apoyo.	Derivación urgente u hospitalización psiquiátrica.

Moderado	Ideación activa, pero sin plan o con buena contención familiar.	Seguimiento estrecho y derivación ambulatoria.
Bajo	Ideación pasiva, sin intención ni plan, buena red de apoyo.	Control periódico, intervención psicosocial.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile 2023)

El manejo incluye **atención médica inmediata, farmacoterapia dirigida, intervención psicosocial y psicoeducación familiar.**

5.1. Fase aguda

Medidas inmediatas

1. **Evaluar y asegurar la seguridad del paciente y del entorno.**
 - Retirar medios letales (armas, medicamentos).
 - No dejar solo al paciente si hay riesgo inminente.
 2. **Evaluar comorbilidades médicas o intoxicaciones.**
 - Control de signos vitales, examen físico completo.
 3. **Derivación urgente a psiquiatría o sala de observación hospitalaria.**
 - Prioridad GES.
 4. **Contención emocional empática:**
 - Escucha activa, sin juicios.
 - Frases tipo: “Entiendo que está sufriendo y quiero ayudarlo.”
-

5.2. Farmacoterapia

- **Antidepresivos ISRS (sertralina, fluoxetina):** en depresión mayor con ideación suicida leve, con estrecho control.
- **Estabilizadores del ánimo (litio, valproato):** reducen riesgo suicida en trastorno bipolar.
- **Antipsicóticos atípicos:** para síntomas psicóticos o agitación.
- **Benzodiacepinas (lorazepam, clonazepam):** uso breve para ansiedad intensa o insomnio.

□ **Litio** es el único fármaco con evidencia robusta de **reducción de mortalidad por suicidio** en bipolaridad y depresión recurrente.

5.3. Psicoterapia

- **Terapia cognitivo-conductual centrada en prevención del suicidio (CBT-SP).**
 - Identificación de pensamientos automáticos suicidas.
 - Plan de seguridad personalizado.
 - **Terapia dialéctico-conductual (DBT):** eficaz en pacientes con impulsividad o trastorno límite.
 - **Terapia de apoyo breve:** en APS o servicios de urgencia.
-

5.4. Psicoeducación familiar

Pilar fundamental para la prevención de recaídas y contención.

Objetivos:

1. Informar sobre el trastorno mental subyacente y su tratamiento.
2. Explicar que el suicidio no es “manipulación”, sino síntoma de enfermedad.
3. Enseñar signos de alarma y conductas protectoras.
4. Reforzar la adherencia farmacológica y controles.
5. Favorecer comunicación y red de apoyo.

Indicaciones prácticas:

- Mantener contacto diario con el paciente en fase de riesgo.
 - Evitar el aislamiento.
 - Controlar acceso a medicamentos y objetos peligrosos.
 - Buscar ayuda médica inmediata ante cualquier recaída.
-

5.5. Seguimiento

- **Controles semanales** en fase aguda.
 - Luego cada 2–4 semanas hasta estabilización.
 - Evaluar adherencia, sueño, ideación y apoyo familiar en cada control.
 - Coordinación con **psiquiatría, psicología y trabajo social**.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones

- **Suicidio consumado.**
- **Intentos repetidos.**
- **Trastornos de ansiedad o abuso de sustancias.**
- **Rechazo familiar o estigmatización.**
- **Hospitalizaciones recurrentes.**

Pronóstico

- **Mejor pronóstico:** detección precoz, apoyo familiar sólido, adherencia terapéutica.

- **Peor pronóstico:** intento grave previo, trastorno bipolar o límite, comorbilidad por alcohol.
 - Intervención integral reduce el riesgo de suicidio en **hasta 80%** de los casos tratados.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **Evaluar el riesgo suicida en toda consulta de salud mental.**
 2. **Intento previo = principal factor de riesgo.**
 3. **Litio** es el único fármaco con efecto protector demostrado.
 4. **No dejar solo al paciente con ideación activa.**
 5. **Psicoeducación familiar** es parte esencial del tratamiento.
 6. **Escucha empática y contención emocional** pueden salvar vidas.
 7. Todo intento suicida **requiere evaluación psiquiátrica.**
-



Errores comunes

- Minimizar la ideación suicida (“no lo dice en serio”).
- Prescribir ISRS sin seguimiento cercano.
- No indagar sobre plan o medios disponibles.
- No comunicar ni involucrar a la familia.
- No derivar a psiquiatría cuando hay riesgo alto.

- Estigmatizar o culpabilizar al paciente.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **riesgo suicida** debe evaluarse activamente en toda entrevista psiquiátrica.
2. Los **principales factores de riesgo** son intento previo, depresión, bipolaridad y abuso de sustancias.
3. La **estratificación del riesgo (alto, moderado, bajo)** orienta la conducta clínica.
4. **Litio** es el único fármaco que **reduce la mortalidad por suicidio**.
5. La **psicoeducación familiar** mejora la adherencia y la detección precoz de recaídas.
6. Todo paciente con **plan suicida o intento reciente** debe ser **derivado o hospitalizado**.
7. La **empatía y escucha activa** son herramientas terapéuticas esenciales del médico.